

약제 급여 평가 위원회 평가 결과

trabectedin 0.25mg, 1.0mg
(온 텔리스주사, 한국얀센)

☐ 제형, 성분·함량 :

- 1 바이알 중 트라벡테딘 0.25mg, 1.0mg (trabectedin)

☐ 효능 효과 :

- 안트라사이클린 및 이포스파마이드 치료요법에 실패했거나, 이들 약제 투여가 부적합한, 진행된 연조직 육종

☐ 약제 급여 평가 위원회 심의 일

2010년 제1차 약제급여평가위원회 : 2010년 1월 21일

2010년 제3차 약제급여평가위원회 : 2010년 3월 25일(재심의)

- 암질환심의위원회 심의일 : 2010년 3월 3일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 1차 심의결과(2010년 제1차 약제급여평가위원회)

○ 재심의

- 신청품은 “안트라사이클린 및 이포스파마이드 치료요법에 실패했거나, 이들 약제 투여가 부적합한, 진행된 연조직 육종”에 허가된 약제로, 제약사가 제출한 세부분석자료에 대하여 추가검토 후 재심의하기로 함.

□ 최종결과(2009년 제11차 약제급여평가위원회)

○ 비급여

- 신청품은 “안트라사이클린 및 이포스파마이드 치료요법에 실패했거나, 이들 약제 투여가 부적합한, 진행된 연조직 육종”에 허가받은 약제로, 대체가능약제에 비해 임상적 유용성 개선이 불분명하나 투약비용이 고가로 비용효과적이지 않으며, 외국 조정 평균가보다 고가이므로 비급여함.
- 제약사가 신청한 급여기준안인 [REDACTED]은 임상적 유용성 및 경제성이 불분명함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “안트라사이클린 및 이포스파마이드 치료요법에 실패했거나, 이들 약제 투여가 부적합한, 진행된 연조직 육종”에 허가받은 약제로 급여목록의 동일적응증에 허가받은 약제는 없으나 급여 기준(건강보험심사평가원 공고) 또는 허가, 임상진료지침, 사전신청요법(신청기관인정요법) 등에 의할 때, gemcitabine+docetaxel 등의 항암화학요법이 있으므로, 진료상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 교과서에서 연조직육종에서 중요한 시험약으로 소개되고, 가이드라인에서는 2차 치료제의 하나로 제시되고 있거나 추천약제에 포함되고 있지 않음.¹⁾²⁾³⁾
- 신청품은 기존 치료제와의 직접비교 임상시험자료가 없음.
- 전이성 또는 절제 불가능한 liposarcoma, leiomyosarcoma 환자로 이전에 anthracycline과 ifosfamide를 사용한 표준요법에 실패한 환자(평가가능환자 260명)를 대상으로 매 3주마

다 신청품 1.5mg/m²(24-h continuous infusion) 투여와 4주 주기로 3주동안 매주 0.58mg/m²(3-h infusion) 투여를 비교하는 개방, 다기관, 무작위 phase II 연구에서⁴⁾

- 1차 평가변수 median TTP는 q3wk 24-h군이(허가상 용법용량) qwk 3-h군에 비해 유의하게 길었음(3.7개월 vs. 2.3개월; HR=0.734, 95%CI, 0.554~0.974; p=0.0302).
 - median PFS는 q3wk 24-h군에서 유의하게 길었으며(3.3개월 vs. 2.3개월; p=0.0418), median OS는 q3wk 24-h군에서 긴 양상을 보임(13.9개월 vs. 11.8개월; p=0.1920). response rate(by RECIST)는 q3wk 24-h군 5.6%, qwk 3-h군 1.6%임.
 - 독성은 주로 grade 3~4의 neutropenia(47%), thrombocytopenia(12%)로 5~7일 이내에 회복하였으며, 일시적 transaminase의 상승(47%)이 발생.
- 1차 이상 이전에 항암화학치료 받은 적이 있는 전이성 또는 절제 불가능한 국소 재발성 연조직 육종 환자(평가가능환자 99명)를 대상으로 매 3주마다 신청품 1.5 mg/m²을 투여한 다기관, 단일군 phase II 시험에서⁵⁾.
- 치료에 대한 반응은 8 부분반응(PR; 8%), 45 불변(no change)이었으며 TTP 중앙값(median duration of the time to progression)은 105일, 6개월 무진행생존은 29% 이었음.
 - 독성은 주로 가역적인 grade 3~4의 무증후성의 transaminases 상승이 40%의 환자에서, grade 3~4의 neutropenia가 52%의 환자에서 관찰됨.
- 이전에 치료 받은 적이 있는 진행성 또는 전이성 연조직 육종 환자 54명에 대하여 신청품 1,500μg/m²을 매 3주마다 투여 [(24-hour intravenous infusion)]한 Phase II 시험에서 전반적 반응률은 3.7%(2명에서 부분반응)임. 무진행생존 중앙값은 1.9 개월; 6개월에서 환자 24%가 무진행생존했음.⁶⁾
- 이전에 치료 받은 적이 있는 전이성 또는 재발성(이전 chemotherapy 에도 불구하고 진행한) 연조직 육종 환자 36명에 대하여 신청품을 1,500μg/m²을 매 3주마다 투여한 Phase II 및 약동학 연구에서 전반적 반응률은 8%(완전반응 1, 부분반응 2)였음. 1년 TTP은 9% 였으며 1년 전반적 생존률은 53%였음. TTP 중앙값은 1.7개월 이었음⁷⁾.

○ 비용 효과성

- 교과서, 가이드라인, 학회의견 등에 2차 요법으로 제시되고 사전신청요법(허가초과)으로 2차 이상에서 인정되고 있는 gemcitabine+docetaxel 요법을 대체가능약제로 선정함.
- 신청품은 대체가능약제 대비 임상적유효성 개선이 불분명하나, 신청품의 1주기 투약비용은 ■■■원⁸⁾으로 대체가능약제인 gemcitabine+docetaxel 요법의 1주기 투약비용인 약 ■■■원⁹⁾ 대비 고가로, 비용효과성이 불분명함.
- 신청품은 반응률 약 5.6%, TTP 3.7개월 등이었고¹⁰⁾, 대체가능약제(gemcitabine+docetaxel)는 gemcitabine과 비교임상논문에서 반응률 약 17%(CR 3%, PR 14%), PFS 6.2개월 등임.¹¹⁾

- 대체가능약제인 gemcitabine+docetaxel 요법은 사전신청요법(허가초과)으로 표준 용법·용량이 공고되지 않고, 신청기관별 용법·용량이 상이한 점¹²⁾ 등을 고려시 대체가능약제의 가중평균가 산출이 곤란함.¹³⁾

- 신청품은 tumor size를 줄이기보다 tumor stabilizing의 효과를 기대하기에는 그 소요비용이 타 약제에 비해 고가로 비급여가 적정함.¹⁴⁾

○ 재정 영향¹⁵⁾

- 2차 약제로 사용시 제약사제시 예상환자수¹⁶⁾를 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액은¹⁷⁾ 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원이 되고, gemcitabine+docetaxel 대체로 재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원으로 증가될 것으로 예상됨.¹⁸⁾
- 다만, 신청품은 전처치 등을 하도록 되어 있으므로 이와 관련하여 재정이 증가할 수 있음.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 독일, 영국, 이탈리아 등재되어 있음.
- 신청품의 신청가는 제외국 조정평균가보다 고가임.¹⁹⁾

Reference

- 1) Cancer 8th ed.
- 2) EMSO(2009)
- 3) NCCN 가이드라인(V2, 2009)
- 4) George D. Demetri et al., Efficacy and Safety of Trabectedin in Patients with Advanced or Metastatic Liposarcoma or Leiomyosarcoma After Failure of Prior Anthracyclines and Ifosfamide : Results of a Randomized Phase II Study of Two Different Schedule. Journal of Clinical Oncology. 2009 DOI:10.1200/JCO.2008.21.0088
- 5) A. Le Cesne et al. Phase II Study of ET-743 in Advanced Soft Tissue Sarcomas: A European Organisation for the Research and Treatment of Cancer (EORTC) Soft Tissue and Bone Sarcoma Group Trial. J Clin Oncol.2005 Jan 20;23(3): 576-84
- 6) A. Yovine et al, Phase II study of ecteinascidin-743 in advanced pretreated soft tissue sarcoma patients. J Clin Oncol. 2004 Mar 1;22(5):890-9
- 7) Garcia-Carbonero et al, Phase II and Pharmacokinetic Study of Ecteinascidin 743 in Patients With Progressive Sarcomas of Soft Tissues Refractory to Chemotherapy. J Clin Oncol. 2004 Apr 15;22(8):1480-90
- 8) 체표면적 1.7(m²), 투여용량은 투여 주기 동안 동일하게 권장용량(1.5 mg/m²)을 사용할 것을 적용. 전처치비용(예: 텍사메타손 20mg=■■■원)이 추가될 수 있음.
- 9) 문헌 및 사전신청요법의 용법·용량 등에 2008년 성분별 가중평균가 적용.

- Maki, et al. Randomized Phase II Study of Gemcitabine and Docetaxel Compared With Gemcitabine Alone in Patients With Metastatic Soft Tissue Sarcomas, J Clin Oncol. 2007;25:2755-2763
 - 암질환심의위원회에서 승인된 gemcitabine+docetaxel 사전신청요법: [REDACTED]
 - 전치료비용(예: docetaxel 사용시 경구용 텍사메타손 16mg/일, 3일=[REDACTED]원)이 추가될 수 있음.
- 10)George D. Demetri et al., Efficacy and Safety of Trabectedin in Patients with Advanced or Metastatic Liposarcoma or Leiomyosarcoma After Failure of Prior Anthracyclines and Ifosfamide : Results of a Randomized Phase II Study of Two Different Schedule. Journal of Clinical Oncology. 2009 DOI:10.1200/JCO.2008.21.0088
- 11)Maki, et al. Randomized Phase II Study of Gemcitabine and Docetaxel Compared With Gemcitabine Alone in Patients With Metastatic Soft Tissue Sarcomas, J Clin Oncol. 2007;25:2755-2763
- 12)항암화학요법의 투여기준 개정 제2009-7호
- : 사전신청 요법은 식약청에서 지정하는 임상시험 실시기관으로서 암관련 전문의가 참여하는 다학제적 위원회를 구성하여 협의한 경우 신청할 수 있으며, 암질환심의위원회에서 인정요법으로 결정된 후 위원회가 인정하는 기관에서 인정하는 범위 안에서 사용할 수 있음.
- 13)신약 등 협상대상 약제의 세부평가기준
- 3.3. 대체약제의 가중평균가 산출이 불가능한 경우
- 대체약제가 없는 경우
 - ※ 단, 진료상 필수약제의 경우, 대체약제 가중평균가 산출 없이도 급여 평가할 수 있음
 - 대체약제 가중평균가 산출이 어렵고, 대체약제 소요비용의 산술평균(또는 중앙값)도 부적절하다고 판단되는 경우
 - 급여기준 등으로 해당 상병코드가 불분명하거나 환자군별 용법·용량 구분이 어려운 경우, 행위 관련 약제가 포함되어 비용 산출이 명확하지 않은 경우 등.
- 14) 2010년 2차(제45차) 암질환심의위원회(2010.3.3)
- 15)동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 16)2009년 제4차 급여평가위원회 평가시 제출된 예상환자수
- 17)투여주기 6주기 적용시 절대재정소요금액 = 제약사제시 대상환자수 x 6 cycle x ((0.25mg 신청가 x 2vial) + (1mg 신청가 x 2vial))
- 18)재정증감액 = 도입후 재정소요금액 - 도입전 재정소요금액
- 19)접수전월 평균환율(최종고시 매매기준율) 적용,
- 신약 등 협상대상 약제의 세부평가기준
- 1.4.2. 외국조정평균가
- 외국조정평균가는 현재 보험급여 약제의 상한금액 조정기준(신의료기술등의결정및조정기준 제9조제4항 제3호 관련[별표3])으로 이용되고 있는 바, 평가시의 신청가격이 이보다 높지 않도록 외국조정평균가를 급여 여부의 평가기준으로 함